

ID Paciente: P004

NHC: NHC-2023-015670

Generado: 09/04/2026

HISTORIA CLÍNICA INTEGRADA

1. Datos del paciente

Nombre completo	Andreu Mas Castelló
Sexo	Hombre
Fecha de nacimiento	17/06/1988 (36 años)
DNI	44.287.163-T
Teléfono	600 987 654
Municipio	Castelló de la Plana
Médico responsable	Dr. Sergio Blanco Navarro
Especialidad	Medicina Interna

2. Antecedentes personales

- Asma alérgica moderada-persistente (diagnóstico infancia, buen control actual)
- Rinitis alérgica perenne (ácaros, gramíneas)
- Obesidad grado II (IMC 37,1 kg/m²)
- SAOS moderado en tratamiento con CPAP nocturna
- Hígado graso no alcohólico (MASLD) estadio F1 por elastografía
- Alergia a penicilina (reacción anafiláctica documentada 2010)

Antecedentes familiares: Madre: obesidad y diabetes tipo 2. Padre: sin antecedentes relevantes.

3. Historia clínica

Paciente de 36 años derivado desde atención primaria por sospecha de síndrome metabólico y hallazgo de elevación de transaminasas en analítica de empresa. Sin consumo de alcohol significativo (< 10 g/día ocasionalmente). Niega consumo de hepatotóxicos ni suplementos herbales. Refiere somnolencia diurna a pesar de uso de CPAP, que atribuye a mal ajuste del dispositivo. Realiza escasa actividad física. Dieta desequilibrada con alto contenido en ultraprocesados. Sin síntomas digestivos actuales.

4. Exploración física

Peso / Talla / IMC	108 kg · 171 cm · 37,1 kg/m ²
Perímetro abdominal	114 cm (riesgo cardiovascular muy alto)
Tensión arterial	134/86 mmHg
Frecuencia cardíaca	76 lpm
Temperatura	36,7 °C

Saturación O2	97 % (aire ambiente)
Auscultación cardiaca	Tonos rítmicos, sin soplos
Auscultación pulmonar	Sibilancias espiratorias leves bilaterales
Abdomen	Obeso. Hepatomegalia de 3 cm de reborde costal, no dolorosa
MMII	Sin edemas. Acantosis nigricans en cuello y axilas

■ 5. Tratamiento farmacológico actual

Medicamento	Posología
Budesonida/Formoterol 320/9 mcg	1 inh. cada 12 h (tratamiento de mantenimiento)
Salbutamol 100 mcg	A demanda (rescate)
Loratadina 10 mg	1 comp. al día (primavera y otoño)
CPAP nocturna	Presión 9 cmH2O, uso recomendado > 6 h/noche

■ 6. Nota de seguimiento — 20/01/2025

Motivo de consulta	Primera visita medicina interna — síndrome metabólico y hepatopatía
--------------------	---

Subjetivo (anamnesis):

Paciente joven motivado para cambiar hábitos. Refiere haber intentado dietas en el pasado sin éxito sostenido. Actualmente con sedentarismo total fuera del trabajo. Uso de CPAP irregular (4-5 h/noche según telemonitorización). Sin cefalea, visión borrosa ni dolor torácico. Sin síntomas de hipoglucemia.

Objetivo (datos clínicos):

Analítica: ALT 78 U/L, AST 52 U/L, GGT 92 U/L. Glucosa basal 108 mg/dL. HbA1c 6,1% (prediabetes). Insulinemia basal 22 mU/L. HOMA-IR 5,9 (resistencia a insulina). Elastografía hepática: 7,1 kPa (F1-F2 borderline).

Plan terapéutico:

- Diagnóstico: síndrome metabólico, MASLD F1-F2, prediabetes por HbA1c 6,1%, SAOS moderado.
- Intervención intensiva en estilo de vida: derivar a programa de obesidad multidisciplinar.
- Objetivo pérdida peso: 10% en 6 meses (10,8 kg). Dieta mediterránea hipocalórica.
- Ejercicio aeróbico: 150 min/semana de intensidad moderada.
- Revisar ajuste CPAP con neumología. Telemonitorización estricta.
- Iniciar metformina 500 mg/día (escalada progresiva) para prediabetes y resistencia insulínica.
- Control analítico en 3 meses. Valorar GLP-1 si no pérdida de peso significativa.
- Próxima revisión en 3 meses con analítica completa.

■ 7. Resultados de laboratorio — 15/01/2025

Parámetro	Resultado	Referencia	Flag	Unidades
Glucosa basal	108	70 – 100	H	mg/dL
HbA1c	6,1	< 5,7	H	%
Insulina basal	22	2 – 10	H	mU/L
HOMA-IR	5,9	< 2,5	H	índice

ALT (GPT)	78	< 40	H	U/L
AST (GOT)	52	< 40	H	U/L
GGT	92	< 55	H	U/L
Bilirrubina total	0,9	< 1,2	N	mg/dL
Colesterol total	212	< 200	H	mg/dL
LDL-c	138	< 130	H	mg/dL
HDL-c	38	> 40	L	mg/dL
Triglicéridos	224	< 150	H	mg/dL
Ácido úrico	7,8	< 7,0	H	mg/dL
TSH	1,8	0,4 – 4,0	N	mUI/L

Observaciones: Perfil metabólico de alto riesgo: resistencia a insulina (HOMA-IR 5,9), prediabetes, dislipemia aterogénica e hipertransaminasemia compatible con MASLD. Hiperuricemia asintomática a vigilar. No se indica alopurinol por el momento.

Documento de uso exclusivo para investigación. Todos los datos son ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de información biomédica y clínica.